

إعادة بناء الحالب جراحة لإصلاح الحالب المسدود أو الضيق — الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة — لاستعادة التصريف الحر وحماية الكلية. تعتمد طريقة الإصلاح على موضع التضيق وطوله؛ وقد يستخدم الجراح طرفي الحالب ذاتهما أو طعماً نسيجياً أو قطعة من الأمعاء.

عن هذا الإجراء

يحبس التضيق (ضيق ندبي) في الحالب البول ويجهد الكلية. يُختار الإصلاح وفق درجة التضيق:

- **تضيق قصير** — يُستأصل الجزء التالف ويُخاط الطرفان الصحيحان، أو يُعاد توصيل الحالب بالمثانة (وقد يُرفع قبة المثانة للأعلى للوصول إليه).
- **تضيق أطول** — يُوسّع الحالب بطعم، غالباً قطعة صغيرة من داخل خذك (لهذا الإجراء نشرة مستقلة).
- **تلف شديد أو طويل جداً** — تُستخدم قطعة من أمعائك لجسر المنطقة التالفة أو استبدالها.

يُوضع دعامة داخلية لينة للإبقاء على الإصلاح مفتوحاً أثناء الشفاء. تُجرى الجراحة عادةً بالمنظار الروبوتي أو الاعتيادي (جروح صغيرة)، وأحياناً مفتوحة. ونسبة النجاح مرتفعة.

هل هو آمن؟

هذه إصلاحات راسخة وفعّالة، مُصمّمة وفق تشريحك. كأى جراحة كبرى، ثمة بعض المخاطر: نزيف، أو عدوى، أو تسرب بولي مؤقت (يُعالج عادةً بالدعامة والتصريف). نادراً ما يعود التضيق. إن استُخدمت قطعة من الأمعاء، يحتاج الجهاز الهضمي بضعة أيام للتعافي وقد تلاحظ مخاطاً في البول.

تعلم المصطلحات

الحالب

الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة.

التضيق (Stricture)

ضيق ندبي يُبطئ تدفق البول أو يوقفه.

دعامة الحالب (Stent)

أنبوب داخلي لين («دبل جيه») يُبقي الإصلاح مفتوحاً أثناء الشفاء.

الطعم (Graft)

رقعة صغيرة من نسيجك، غالباً من داخل الخد، لتوسيع الحالب.

قطعة الأمعاء

جزء قصير من أمعائك لجسر فراغ طويل في الحالب.

إعادة الزرع (Reimplantation)

إعادة توصيل الحالب بالمثانة.

استسقاء الكلية (Hydronephrosis)

تورم الكلية بسبب تراكم البول خلف الانسداد.

روبوتي / منطاري

جراحة بجروح صغيرة عبر شقوق محدودة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها، توقّع ألماً في موضع الشقوق، وقد تسبّب الدعامة الداخلية إلحاح التبول أو وخزاً خفيفاً في الخصرة. إن استُخدمت قطعة من الأمعاء، فسيحتاج جهازك الهضمي بضعة أيام ليعود للعمل. يمكث معظم المرضى 1-3 ليالٍ، ومدة العملية تعتمد على نوع الإصلاح.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- الجراحة تحت التخدير العام — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف الأدوية، بما فيها مميّعات الدم).
- فحص البول للكشف عن العدوى — يجب علاج أي عدوى قبل الجراحة.
- لا تدخّن — يُبطئ التئام الجروح. إن احتُمِل استخدام قطعة من الأمعاء، قد تحتاج تحضير الأمعاء؛ وإن احتُمِل استخدام طُعْم من الخد، اعتنِ بفمك.
- خطّط لوجود دعامة لمدة 4-6 أسابيع، ورتّب من يوصلك إلى المنزل.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:

- تتناول مميّعات الدم، أو لديك عدوى حالية
- أجريت جراحة بطنية أو حوضية سابقة أو تلقّيت إشعاعاً

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تنام تحت التخدير وتُعطى لك مضادات حيوية.
- 2 يُجري الجراح شقوقاً صغيرة أو مفتوحة ويصل إلى الجزء الضيق.
- 3 يُصلح الحالب — بربط الطرفين، أو رقعته بطُعْم، أو جسره بقطعة من الأمعاء — فوق دعامة داخلية.
- 4 يُترك تصريف صغير عند الحاجة، ثم تُغلق الشقوق.

بعد الجراحة

- عادةً تعود للمنزل في 1-3 أيام.
- تبقى الدعامة داخلياً نحو 4-6 أسابيع، ثم تُزال بتتنظير سريع في العيادة.
- أعراض الدعامة — إلحاح التبول، وخز خفيف في الخصرة، أو بول وردي — طبيعية.
- إن استُخدمت قطعة أمعاء، تناول طعاماً خفيفاً أثناء التعافي. تجنّب رفع الأثقال لأسابيع.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- ألم شديد أو متصاعد في الخصرة أو البطن
- نزيف غزير، أو عجز عن التبول
- قيء مستمر، أو غياب الغازات أو البراز (إن استُخدمت الأمعاء)
- احمرار متزايد أو ألم أو إفراز عند أحد الشقوق

ثلاثة أمور تذكّرها

1. تُعيد هذه الجراحة فتح الحالب المسدود لحماية الكلية. يُصمّم الإصلاح وفق حالتك: ربط الطرفين، أو طُعْم من الخد، أو قطعة من الأمعاء، فوق دعامة داخلية.
2. للاستعداد: اتّبع تعليمات الصيام والأدوية، عالج أي عدوى أولاً، لا تدخّن، خطّط للدعامة لمدة 4-6 أسابيع، ورتّب من يوصلك.
3. توقّع أن تسبّب الدعامة بعض الإلحاح حتى تُزال في العيادة. اتصل فوراً عند الحمّى، أو الألم الشديد، أو النزيف الغزير، أو العجز عن التبول، أو توقّف حركة الأمعاء.